

МЕТА30

5 вопросов, которые нужно задать себе перед началом кето-протокола

*Образовательный чеклист для тех, кто рассматривает
кетогенное питание во время противораковой терапии*

Этот документ поможет вам понять, подходит ли кетогенный протокол в вашей ситуации,
и подготовиться к разговору с врачом.

meta30.ru

01

Теряет ли ваш близкий (или вы) вес непреднамеренно?

Если человек уже теряет вес без причины — приоритет не ограничение углеводов, а калории и белок. Кетогенное питание ограничивает углеводы и может снизить аппетит, что при непреднамеренной потере веса создаёт дополнительный риск. Что делать: Если потеря веса составляет более 5% за последние 3 месяца — обсудите любые изменения питания с лечащим врачом до начала протокола. В МΕΤΑ30 этот вопрос входит в скрининг: при потере веса продукт не предлагается без согласования с врачом.

02

Есть ли серьёзные проблемы с почками, печенью или поджелудочной?

Кетогенный рацион создаёт дополнительную нагрузку на эти органы. Печень активно участвует в производстве кетонов. Почки выводят больше продуктов метаболизма. Поджелудочная железа адаптируется к изменённому балансу макросов. Что делать: При диагностированных заболеваниях почек (ХБП стадии 3+), печени или панкреатите — согласуйте любые диетические изменения с профильным специалистом. Это не значит, что кето невозможно. Это значит, что решение принимается совместно с врачом.

03

Есть ли диабет 1 типа или приём препаратов, снижающих сахар?

Диабет 1 типа — абсолютное противопоказание для самостоятельного перехода на кетогенное питание. Риск кетоацидоза — реальный и опасный. При диабете 2 типа с приёмом препаратов (метформин, инсулин, препараты сульфонилмочевины) — снижение углеводов может потребовать корректировки дозировок. Без контроля врача это опасно. Что делать: Не начинайте кетогенный протокол при диабете 1 типа. При диабете 2 типа — обязательно согласуйте со своим эндокринологом.

04

Есть ли расстройства пищевого поведения в анамнезе?

Структурированный рацион с подсчётом макросов может усилить тревогу вокруг еды у людей с историей РПП — орторексии, анорексии, компульсивного переедания. То, что помогает большинству, для человека с таким опытом может стать триггером. Что делать: Если есть текущие или прошлые проблемы с пищевым поведением — обсудите переход на структурированный рацион с психотерапевтом или специалистом по РПП. Еда должна поддерживать, а не становиться источником стресса.

05

Обсуждали ли вы изменения в питании с лечащим врачом?

Это не формальность. Онколог знает клиническую картину, текущую терапию, взаимодействия препаратов. Он может увидеть то, чего вы не видите. Многие врачи не говорят о питании не потому, что им всё равно — а потому, что нутрициология занимает несколько часов за весь курс медицинского образования. Ваша задача — начать разговор. Как начать: Не приносите распечатки исследований. Скажите просто: «Я хочу снизить сахар и есть больше овощей и рыбы. Есть ли у меня противопоказания?» Это работает лучше, чем «я читала про эффект Варбурга». Если хотите дать врачу краткое описание протокола — скачайте бесплатную "Сводку для врача" на meta30.ru.

**Если на все 5 вопросов ответ вас не останавливает —
МЕТА30 может быть подходящим инструментом.**

МЕТА30 — это 30-дневный образовательный протокол кетогенного питания для людей во время противораковой терапии. Готовое меню на каждый день, три уровня калорий, списки покупок, рецепты-заготовки, образовательные материалы.

Цена: 4 990 руб. (33 руб. за приём пищи)

meta30.ru

МЕТА30 — образовательный протокол питания. Не является медицинской услугой, не заменяет врача, не содержит медицинских назначений. Решение о корректировке питания принимается совместно с лечащим врачом.

Макросы рассчитаны приблизительно и могут отличаться в зависимости от производителя, способа приготовления и размера порции.

Контакты: support@meta30.ru | [@meta30_support_bot](https://t.me/meta30_support_bot) | vk.com/meta30